Masterprompt:

Aufgabe
Erstelle auf Basis der hochgeladenen Quellen einen Fragebogen zur Messung von Akzeptanz von KI-gestützten Systemen bei medizinischen Behandlungen bei Patientinnen und Patienten. Schlage dazu eine oder mehrere passende Theorien vor, aus denen die Fragen abgeleitet werden.
Zielgröße
Gegenstand der Befragung ist KI-gestützte Gesundheitsinformationssysteme bei der eigenen Behandlung. Gemessen werden die Nutzungsabsicht und die Faktoren, die sie beeinflussen.
Arbeitsschritte
Arbeite die folgenden Schritte nacheinander ab. Beginne einen Schritt erst, wenn der vorherige abgeschlossen ist.

1. Theorie: Wähle aus den Quellen eine oder mehrere Theorien aus. Begründe die Wahl.
2. Modell und Hypothesen: Leite aus der gewählten Theorie ein Modell ab. Formuliere jeden angenommenen Zusammenhang zwischen zwei Konstrukten als Hypothese. Gib bei jeder Hypothese die Richtung an (+ oder −) und die Quelle, aus der sie abgeleitet ist. Übernimm die Richtung aus dieser Quelle. Maßgeblich ist die dort formulierte Hypothese, nicht das empirische Ergebnis.
3. Konstrukte: Liste alle Konstrukte des Modells auf, die im Fragebogen gemessen werden.
4. Items: Erstelle für jedes Konstrukt 3 bis 5 Items.

Theorievergleich
Gehe in Schritt 1 so vor:

1. Liste alle Theorien auf, die in den Quellen vorkommen.
2. Prüfe für jede Theorie, wie gut sie zur Zielgröße passt.
3. Begründe für jede Theorie, warum du sie aufnimmst oder nicht. Gib diesen Vergleich im Teil „Theorie und Begründung“ aus.

Perspektive
Formuliere alle Items aus Sicht der befragten Person: in der Ich-Form und bezogen auf sich selbst. Formuliere keine Items aus Sicht der Organisation (z. B. mit „wir“ oder „unser Unternehmen“).
Quellenregel
Übernimm Items nur aus Skalen, die in den Quellen stehen. Du darfst nur drei Dinge anpassen: den Gegenstand des Items (die Technologie), die Perspektive und die Sprache. Items aus anderssprachigen Skalen übersetzt du sinngleich ins Deutsche. Alles andere bleibt im Wortlaut gleich, bei übersetzten Items im Sinn gleich. Füge nichts hinzu, lass nichts weg und lege keine Items zusammen. Die Sprache einer Skala ist kein Kriterium für die Theoriewahl. Verwende für den Gegenstand in allen Items dieselbe Bezeichnung. Gib zu jedem Item die Quelle an: den Fragebogen oder das Paper und die Item-Nummer bzw. -Kennung, wie sie in der Quelle steht. Gib nicht den Originaltext an. Wie viele Items du übernimmst, richtet sich nach der Skala in der Quelle:

- Hat die Skala 3 bis 5 Items, übernimm alle.
- Hat die Skala mehr als 5 Items, übernimm die ersten 5 in der Reihenfolge der Quelle.
- Hat die Skala weniger als 3 Items, übernimm alle und ergänze neu formulierte Items, bis das Konstrukt 3 Items hat. Wenn es für ein Konstrukt keine passende Skala in

den Quellen gibt, formuliere die Items neu. Markiere jedes neu formulierte Item als „neu formuliert“ und gib keine Quelle an. Markiere jedes übersetzte Item mit „(übersetzt)“. Markiere ein Item nur dann mit „(invers)“, wenn es in der Originalskala negativ formuliert ist. Ergänze in der Tabelle die Spalte Quelle.

Ausgabeformat

Gib das Ergebnis in genau dieser Reihenfolge aus:

1. Theorie und Begründung
2. Modell mit Hypothesen (Format: H1: Konstrukt A → Konstrukt B (+/−), Quelle: …)
3. Liste der Konstrukte
4. Fragebogen als Tabelle mit den Spalten: Konstrukt | Item | Antwortskala Jede Zeile enthält genau ein Item.

Gib ausschließlich diese vier Teile aus. Füge keine weiteren Abschnitte, Kapitel oder Ergänzungen hinzu.

Ausgabelänge

Gib die Antwortskala nur einmal direkt über der Tabelle an. Die Spalte Antwortskala entfällt.

Response:

1. Theorie und Begründung

In den Quellen (insbesondere Wichmann et al., 2024) werden verschiedene etablierte Theorien aus der Gesundheitsforschung, der Wirtschaftsinformatik und der Psychologie herangezogen und verglichen:

1. Health Belief Model (HBM) (Hochbaum, 1958; Rosenstock, 1960, 1974):

- *Passung zur Zielgröße:* Erklärt gesundheitsbezogenes Verhalten primär durch krankheitsbezogene Bedrohungen (Schweregrad, Verwundbarkeit) und Nutzen-Kosten-Abwägungen präventiver Maßnahmen[1][2].
- *Begründung für Aufnahme/Ablehnung:* Das HBM wird als Teilkomponente aufgenommen, da es krankheitsbezogene Wahrnehmungen gut abbildet. Als alleinige Theorie reicht es jedoch nicht aus, da spezifische technologie- und verhaltensbezogene Akzeptanzfaktoren von Informationssystemen fehlen.

2. Protection Motivation Theory (PMT) (Rogers, 1975; Floyd et al., 2006):

- *Passung zur Zielgröße:* Basiert auf dem Dualitätsansatz (*Duality Approach*) und unterscheidet zwischen der Bewertung der Bedrohung durch die Krankheit (*nicht-adaptive Bewertung*) und der Bewertung der Bewältigungsmöglichkeit bzw. Behandlung (*adaptive Bewertung*)[2][3].
- *Begründung für Aufnahme/Ablehnung:* Die PMT wird als theoretisches Kernfundament aufgenommen, da sie die Abwägung zwischen krankheitsbedingten Ängsten/Risiken und behandlungsbezogenen Vorteilen bei medizinischen Entscheidungen präzise strukturiert.

3. Extended Parallel Process Model (EPPM) (Witte, 1994, 2009):

- *Passung zur Zielgröße:* Ergänzt die PMT um die Unterscheidung kognitiver Prozesse der Gefahrenkontrolle (*Danger Control*) und emotionaler Prozesse der Furchtkontrolle (*Fear Control*)[2][4].
- *Begründung für Aufnahme/Ablehnung:* Das EPPM wird als Teilkomponente aufgenommen, da es die theoretische Grundlage bietet, um emotionale Reaktionen (Furcht vor der Krankheit vs. Furcht vor dem KI-System) zu berücksichtigen.

4. Unified Theory of Acceptance and Use of Technology 2 (UTAUT2) / Technology Acceptance Model (TAM) (Venkatesh et al., 2012; Davis, 1989):

- *Passung zur Zielgröße:* Fokus auf die Akzeptanz von Informationstechnologien über Leistungs- und Aufwandserwartungen, soziale Einflüsse sowie unterstützende Bedingungen[2][5].
- *Begründung für Aufnahme/Ablehnung:* UTAUT2/TAM wird als Teilkomponente aufgenommen, um die technologiebezogenen Einflussfaktoren (z. B. Systemwirksamkeit, Selbstwirksamkeit im Umgang mit KI) abzubilden. Alleine greift es bei medizinischen Behandlungen jedoch zu kurz, da der Krankheitskontext unberücksichtigt bliebe.

5. Reasoned Action Approach (RAA) / Theory of Planned Behavior (TPB) (Fishbein & Ajzen, 2011; Ajzen, 1991):

- *Passung zur Zielgröße:* Erklärt Verhaltensabsichten durch Einstellung, soziale Normen und wahrgenommene Verhaltenskontrolle[6][7].
- *Begründung für Aufnahme/Ablehnung:* RAA/TPB wird als Teilkomponente aufgenommen, da Einstellungen, soziale Normen und Verhaltenskontrollen zentrale Prädikatoren der Nutzungsabsicht darstellen.

Auswahlentscheidung: Es wird das integrierte theoretische Modell von Wichmann et al. (2024) gewählt[8][9]. Dieses Modell führt die fünf genannten Theorien über den Dualitätsansatz (*Duality Approach*) zusammen[3][10]. Da KI-gestützte Gesundheitsinformationssysteme bei der eigenen medizinischen Behandlung sowohl krankheitsbezogene als auch technologie- und verhaltensbezogene Wahrnehmungen ansprechen, bietet nur die Kombination dieser Theorien die notwendige Erklärungsleistung[11].

---

2. Modell mit Hypothesen

Aus dem integrierten theoretischen Modell von Wichmann et al. (2024) werden folgende Hypothesen abgeleitet [30–37]:

- H1: Wahrgenommene Bedrohung → Furcht (Krankheit) (+), Quelle: Wichmann et al. (2024), S. 5–6
- H2: Wahrgenommene Bedrohung → Nutzungsabsicht (+), Quelle: Wichmann et al. (2024), S. 6
- H3: Nicht-adaptive Belohnungen → Furcht (Krankheit) (−), Quelle: Wichmann et al. (2024), S. 6
- H4: Nicht-adaptive Belohnungen → Nutzungsabsicht (−), Quelle: Wichmann et al. (2024), S. 6
- H5: Furcht (Krankheit) → Einstellung (Krankheit) (+), Quelle: Wichmann et al. (2024), S. 6
- H6: Einstellung (Krankheit) → Nutzungsabsicht (+), Quelle: Wichmann et al. (2024), S. 6
- H7: Wahrgenommene Wirksamkeit → Furcht (KI-System) (−), Quelle: Wichmann et al. (2024), S. 6
- H8: Wahrgenommene Wirksamkeit → Einstellung (KI-System) (+), Quelle: Wichmann et al. (2024), S. 6
- H9: Wahrgenommene Wirksamkeit → Nutzungsabsicht (+), Quelle: Wichmann et al. (2024), S. 6
- H10: Furcht (KI-System) → Einstellung (KI-System) (−), Quelle: Wichmann et al. (2024), S. 6
- H11: Einstellung (KI-System) → Nutzungsabsicht (+), Quelle: Wichmann et al. (2024), S. 6

- H12: Wahrgenommene Normen → Wahrgenommene Bedrohung (+), Quelle: Wichmann et al. (2024), S. 6
- H13: Wahrgenommene Normen → Furcht (Krankheit) (+), Quelle: Wichmann et al. (2024), S. 6
- H14: Wahrgenommene Normen → Nutzungsabsicht (+), Quelle: Wichmann et al. (2024), S. 6
- H15: Wahrgenommene Normen → Einstellung (KI-System) (+), Quelle: Wichmann et al. (2024), S. 6
- H16: Wahrgenommene Normen → Wahrgenommene Wirksamkeit (+), Quelle: Wichmann et al. (2024), S. 6
- H17: Wahrgenommene Normen → Einstellung (Krankheit) (−), Quelle: Wichmann et al. (2024), S. 6
- H18: Wahrgenommene Normen → Furcht (KI-System) (−), Quelle: Wichmann et al. (2024), S. 6
- H19: Wahrgenommene Normen → Nicht-adaptive Belohnungen (−), Quelle: Wichmann et al. (2024), S. 6
- H20: Fähigkeiten (KI-System) → Wahrgenommene Wirksamkeit (+), Quelle: Wichmann et al. (2024), S. 6
- H21: Fähigkeiten (KI-System) → Furcht (KI-System) (+), Quelle: Wichmann et al. (2024), S. 6
- H22: Fähigkeiten (KI-System) → Einstellung (KI-System) (+), Quelle: Wichmann et al. (2024), S. 6
- H23: Fähigkeiten (KI-System) → Wahrgenommene Kosten/Barrieren (+), Quelle: Wichmann et al. (2024), S. 6
- H24: Fähigkeiten (KI-System) → Nutzungsabsicht (+), Quelle: Wichmann et al. (2024), S. 6
- H25: Wahrgenommene Kosten/Barrieren → Wahrgenommene Wirksamkeit (−), Quelle: Wichmann et al. (2024), S. 6
- H26: Wahrgenommene Kosten/Barrieren → Einstellung (KI-System) (−), Quelle: Wichmann et al. (2024), S. 6
- H27: Wahrgenommene Kosten/Barrieren → Nutzungsabsicht (−), Quelle: Wichmann et al. (2024), S. 6

---

3. Liste der Konstrukte

Im Fragebogen werden folgende 13 Konstrukte gemessen[14][15]:

1. Nutzungsabsicht (*Intention to use*)
2. Einstellung gegenüber dem KI-System (*Attitude - HIS*)
3. Einstellung gegenüber der Krankheit (*Attitude - disease*)
4. Wahrgenommene Normen (*Perceived norms*)
5. Wahrgenommene Selbstwirksamkeit / Verhaltenskontrolle (*Perceived behavioral control / self-efficacy*)
6. Wahrgenommene Systemwirksamkeit (*Perceived response efficacy / HIS efficacy*)
7. Furcht vor dem KI-System (*Fear - HIS*)
8. Furcht vor der Krankheit (*Fear - disease*)
9. Nicht-adaptive Belohnungen (*Nonadaptive rewards*)
10. Wahrgenommene Verwundbarkeit (*Perceived threat vulnerability*)
11. Wahrgenommener Schweregrad (*Perceived threat severity*)
12. Fähigkeiten im Umgang mit dem KI-System (*Abilities - HIS*)

13. Wahrgenommene Kosten und Barrieren (*Perceived costs/barriers - HIS*)

4. Fragebogen als Tabelle
Antwortskala: 7-stufige Likert-Skala (1 = „Trifft überhaupt nicht zu“ bis 7 = „Trifft voll und ganz zu“)

Konstrukt	Item	Quelle
Nutzungsabsicht	Ich beabsichtige, das KI-gestützte Gesundheitsinformationssystem bei meiner medizinischen Behandlung zu nutzen. (übersetzt)	Wichmann et al. (2024) / Fishbein & Ajzen (2011), Item INT1
Nutzungsabsicht	Ich plane, das KI-gestützte Gesundheitsinformationssystem bei meiner medizinischen Behandlung in Anspruch zu nehmen. (übersetzt)	Wichmann et al. (2024) / Fishbein & Ajzen (2011), Item INT2
Nutzungsabsicht	Ich bin entschlossen, das KI-gestützte Gesundheitsinformationssystem bei meiner medizinischen Behandlung zu verwenden. (übersetzt)	Wichmann et al. (2024) / Fishbein & Ajzen (2011), Item INT3
Einstellung gegenüber dem KI-System	Die Nutzung des KI-gestützten Gesundheitsinformationssystems bei meiner Behandlung halte ich für eine gute Idee. (übersetzt)	Wichmann et al. (2024) / Fishbein & Ajzen (2011), Item ATT_HIS1
Einstellung gegenüber dem KI-System	Ich finde den Einsatz des KI-gestützten Gesundheitsinformationssystems bei meiner Behandlung vorteilhaft. (übersetzt)	Wichmann et al. (2024) / Fishbein & Ajzen (2011), Item ATT_HIS2
Einstellung gegenüber dem KI-System	Die Verwendung des KI-gestützten Gesundheitsinformationssystems bei meiner Behandlung beurteile ich positiv. (übersetzt)	Wichmann et al. (2024) / Fishbein & Ajzen (2011), Item ATT_HIS3
Einstellung gegenüber dem KI-System	Ich schätze die Nutzung des KI-gestützten Gesundheitsinformationssystems bei meiner Behandlung als nützlich ein. (übersetzt)	Wichmann et al. (2024) / Fishbein & Ajzen (2011), Item ATT_HIS4
Einstellung gegenüber dem KI-System	Die Behandlung mithilfe des KI-gestützten Gesundheitsinformationssystems empfinde ich als klug. (übersetzt)	Wichmann et al. (2024) / Fishbein & Ajzen (2011), Item ATT_HIS5
Einstellung gegenüber der Krankheit	Ich halte eine aktive Auseinandersetzung mit meiner Erkrankung für wichtig. (übersetzt)	Wichmann et al. (2024) / Fishbein & Ajzen (2011), Item ATT_DIS1
Einstellung gegenüber der Krankheit	Ich finde es notwendig, medizinische Maßnahmen gegen meine Erkrankung zu ergreifen. (übersetzt)	Wichmann et al. (2024) / Fishbein & Ajzen (2011), Item ATT_DIS2

Einstellung gegenüber der Krankheit	Ich stehe einer gezielten Behandlung meiner Erkrankung positiv gegenüber. (übersetzt)	Wichmann et al. (2024) / Fishbein & Ajzen (2011), Item ATT_DIS3
Einstellung gegenüber der Krankheit	Ich schätze das Ergreifen von Maßnahmen gegen meine Erkrankung als sinnvoll ein. (übersetzt)	Wichmann et al. (2024) / Fishbein & Ajzen (2011), Item ATT_DIS4
Einstellung gegenüber der Krankheit	Ich halte es für klug, meine Erkrankung medizinisch behandeln zu lassen. (übersetzt)	Wichmann et al. (2024) / Fishbein & Ajzen (2011), Item ATT_DIS5
Wahrgenommene Normen	Personen, die mir wichtig sind, denken, dass ich das KI-gestützte Gesundheitsinformationssystem nutzen sollte. (übersetzt)	Wichmann et al. (2024) / Fishbein & Ajzen (2011), Item PN1
Wahrgenommene Normen	Menschen, deren Meinung ich schätze, würden die Nutzung des KI-gestützten Gesundheitsinformationssystems befürworten. (übersetzt)	Wichmann et al. (2024) / Fishbein & Ajzen (2011), Item PN2
Wahrgenommene Normen	Mein soziales Umfeld erwartet von mir, dass ich das KI-gestützte Gesundheitsinformationssystem bei meiner Behandlung verwende. (übersetzt)	Wichmann et al. (2024) / Fishbein & Ajzen (2011), Item PN3
Wahrgenommene Normen	Die meisten Personen in meinem Umfeld würden es begrüßen, wenn ich das KI-gestützte Gesundheitsinformationssystem nutze. (übersetzt)	Wichmann et al. (2024) / Fishbein & Ajzen (2011), Item PN4
Wahrgenommene Selbstwirksamkeit / Verhaltenskontrolle	Ich habe die notwendigen Mittel und Ressourcen, um das KI-gestützte Gesundheitsinformationssystem zu nutzen. (übersetzt)	Wichmann et al. (2024) / Fishbein & Ajzen (2011), Item PBC1
Wahrgenommene Selbstwirksamkeit / Verhaltenskontrolle	Ich kann selbst entscheiden, ob ich das KI-gestützte Gesundheitsinformationssystem verwende. (übersetzt)	Wichmann et al. (2024) / Fishbein & Ajzen (2011), Item PBC2
Wahrgenommene Selbstwirksamkeit / Verhaltenskontrolle	Es liegt ganz bei mir, das KI-gestützte Gesundheitsinformationssystem bei meiner Behandlung einzusetzen. (übersetzt)	Wichmann et al. (2024) / Fishbein & Ajzen (2011), Item PBC3
Wahrgenommene Selbstwirksamkeit / Verhaltenskontrolle	Ich besitze das nötige Wissen, um das KI-gestützte Gesundheitsinformationssystem zu bedienen. (übersetzt)	Wichmann et al. (2024) / Fishbein & Ajzen (2011), Item PBC4
Wahrgenommene Systemwirksamkeit	Das KI-gestützte Gesundheitsinformationssystem ist effektiv darin,	Wichmann et al. (2024) / Taheri-

	meine medizinische Behandlung zu unterstützen. (übersetzt)	Kharameh et al. (2020), Item PRE1
Wahrgenommene Systemwirksamkeit	Die Nutzung des KI-gestützten Gesundheitsinformationssystems verbessert den Erfolg meiner Behandlung. (übersetzt)	Wichmann et al. (2024) / Taheri-Kharameh et al. (2020), Item PRE2
Wahrgenommene Systemwirksamkeit	Das KI-gestützte Gesundheitsinformationssystem stellt eine wirksame Maßnahme dar, um meine gesundheitlichen Beschwerden zu lindern. (übersetzt)	Wichmann et al. (2024) / Taheri-Kharameh et al. (2020), Item PRE3
Furcht vor dem KI-System	Der Gedanke an den Einsatz des KI-gestützten Gesundheitsinformationssystems bei meiner Behandlung macht mir Angst. (übersetzt)	Wichmann et al. (2024) / Izard et al. (1993), Item FEA_HIS1
Furcht vor dem KI-System	Ich fühle mich ängstlich, wenn ich an eine Behandlung durch das KI-gestützte Gesundheitsinformationssystem denke. (übersetzt)	Wichmann et al. (2024) / Izard et al. (1993), Item FEA_HIS2
Furcht vor dem KI-System	Der Einsatz des KI-gestützten Gesundheitsinformationssystems löst bei mir ein beunruhigendes Gefühl aus. (übersetzt)	Wichmann et al. (2024) / Izard et al. (1993), Item FEA_HIS3
Furcht vor der Krankheit	Der Gedanke an meine Erkrankung löst bei mir Angst aus. (übersetzt)	Wichmann et al. (2024) / Izard et al. (1993), Item FEA_DIS1
Furcht vor der Krankheit	Ich fühle mich unruhig und besorgt wegen meiner Erkrankung. (übersetzt)	Wichmann et al. (2024) / Izard et al. (1993), Item FEA_DIS2
Furcht vor der Krankheit	Meine Erkrankung macht mir große Sorgen. (übersetzt)	Wichmann et al. (2024) / Izard et al. (1993), Item FEA_DIS3
Nicht-adaptive Belohnungen	Wenn ich das KI-gestützte Gesundheitsinformationssystem nicht nutze, erspare ich mir den Aufwand, ein neues System kennenzulernen. (übersetzt)	Wichmann et al. (2024) / Vance et al. (2012), Item NR1
Nicht-adaptive Belohnungen	Der Verzicht auf das KI-gestützte Gesundheitsinformationssystem erlaubt es mir, bei meinen gewohnten Behandlungsabläufen zu bleiben. (übersetzt)	Wichmann et al. (2024) / Vance et al. (2012), Item NR2
Nicht-adaptive	Die Beibehaltung meiner bisherigen Behandlung	Wichmann et al.

Belohnungen	ohne das KI-gestützte Gesundheitsinformationssystem gibt mir ein vertrautes Gefühl. (übersetzt)	(2024) / Vance et al. (2012), Item NR3
Wahrgenommene Verwundbarkeit	Ich schätze mein Risiko als hoch ein, von den negativen Auswirkungen meiner Erkrankung betroffen zu sein. (übersetzt)	Wichmann et al. (2024) / Ku & Hsieh (2018), Item PV1
Wahrgenommene Verwundbarkeit	Es ist wahrscheinlich, dass meine Gesundheit ohne passende Behandlung Schaden nimmt. (übersetzt)	Wichmann et al. (2024) / Ku & Hsieh (2018), Item PV2
Wahrgenommene Verwundbarkeit	Ich halte mich für anfällig für gesundheitliche Komplikationen im Zusammenhang mit meiner Erkrankung. (übersetzt)	Wichmann et al. (2024) / Ku & Hsieh (2018), Item PV3
Wahrgenommene Verwundbarkeit	Die Wahrscheinlichkeit, dass sich mein Gesundheitszustand ohne Intervention verschlechtert, ist für mich hoch. (übersetzt)	Wichmann et al. (2024) / Ku & Hsieh (2018), Item PV4
Wahrgenommener Schweregrad	Wenn sich meine Erkrankung verschlimmert, hätte dies schwerwiegende Folgen für mein Leben. (übersetzt)	Wichmann et al. (2024) / Ku & Hsieh (2018), Item PS1
Wahrgenommener Schweregrad	Die gesundheitlichen Beeinträchtigungen durch meine Erkrankung empfinde ich als gravierend. (übersetzt)	Wichmann et al. (2024) / Ku & Hsieh (2018), Item PS2
Wahrgenommener Schweregrad	Meine Erkrankung beeinträchtigt meine täglichen Aktivitäten erheblich. (übersetzt)	Wichmann et al. (2024) / Ku & Hsieh (2018), Item PS3
Wahrgenommener Schweregrad	Ein Voranschreiten meiner Erkrankung würde meine Lebensqualität stark mindern. (übersetzt)	Wichmann et al. (2024) / Ku & Hsieh (2018), Item PS4
Wahrgenommener Schweregrad	Die möglichen Folgeschäden meiner Erkrankung machen mir das Ausmaß der Bedrohung bewusst. (übersetzt)	Wichmann et al. (2024) / Ku & Hsieh (2018), Item PS5
Fähigkeiten im Umgang mit dem KI-System	Ich verstehe die Funktionsweise des KI-gestützten Gesundheitsinformationssystems schnell. (neu formuliert)	neu formuliert
Fähigkeiten im Umgang mit dem KI-System	Ich fühle mich fähig, die Rückmeldungen des KI-gestützten Gesundheitsinformationssystems richtig einzuordnen. (neu formuliert)	neu formuliert
Fähigkeiten im Umgang	Ich verfüge über ausreichende digitale	neu formuliert

mit dem KI-System	Kompetenzen, um mit dem KI-gestützten Gesundheitsinformationssystem umzugehen. (neu formuliert)	
Wahrgenommene Kosten und Barrieren	Die Nutzung des KI-gestützten Gesundheitsinformationssystems ist für mich mit einem hohen zeitlichen Aufwand verbunden. (neu formuliert)	neu formuliert
Wahrgenommene Kosten und Barrieren	Ich sehe finanzielle oder praktische Hürden bei der Nutzung des KI-gestützten Gesundheitsinformationssystems. (neu formuliert)	neu formuliert
Wahrgenommene Kosten und Barrieren	Es fällt mir schwer, Zugang zu dem KI-gestützten Gesundheitsinformationssystem zu erhalten. (neu formuliert)	neu formuliert